AllattAmore



"Il manuale a portata di mamma"



E' L'AMORE CHE NUTRE

L'importanza del latte materno



Il neonato necessita immediatamente di instaurare una relazione con la mamma durante l'esperienza della nutrizione. Si tratta di piccole percezioni (il contatto con la pelle, il calore, l'odore, il suono della voce) che cominciano a **dare un senso alla vita del bambino.** L' allattamento materno **favorisce il legame madre-bambino**, soddisfacendo e rafforzando il vostro bisogno reciproco di **stare insieme**.

Per assicurare fin dalla nascita la salute, l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Unicef e le associazioni mediche di tutto il mondo raccomandano l'**allattamento esclusivo al seno** per i primi 6 mesi di vita, seguito da un allattamento al seno complementare fino ai 2 anni e oltre.
Il latte materno è ricco di anticorpi ed enzimi che proteggono il tuo bambino, è immediatamente assimilabile e facilmente digeribile, è molto pratico e veloce perchè non ha bisogno di essere mescolato con altre sostanze o di essere sterilizzato, ha una temperatura ideale e non richiede l'uso di alcuno strumento esterno.

Allattare fa bene a mamma e bambino



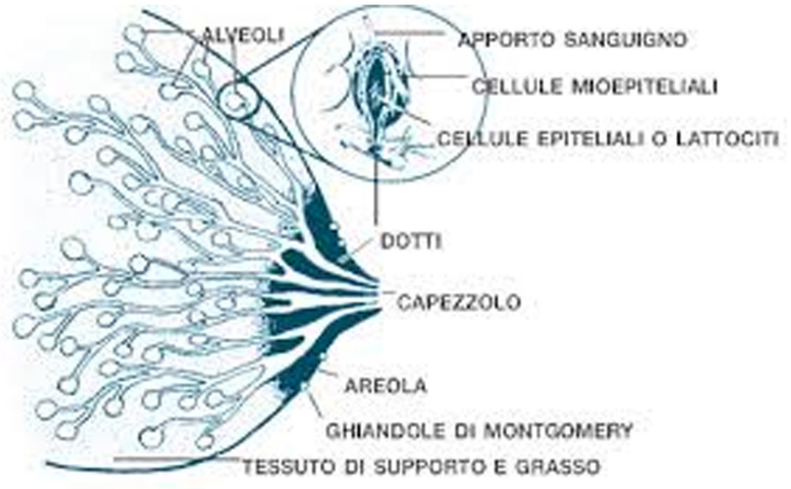
Benefici per te mamma

Fin dalle prime 24 ore dal parto l'allattamento al seno rafforza il legame fra madre e figlio e getta le basi per una relazione fatta di affetto e fiducia.
E' stato dimostrato da ricerche scientifiche che le donne che hanno allattato al seno hanno meno possibilità di sviluppare tumori alla mammella e osteoporosi.
Si riprendono inoltre prima dai postumi di gravidanza e parto e diminuisce il rischio di depressione post-parto

Benefici per il tuo bambino

Il neonato grazie al latte della mamma può costruirsi una sua flora batterica intestinale e un suo proprio sistema immunitario che formandosi piano piano imparerà a difenderlo dal mondo esterno dal quale è stato protetto nel ventre materno nei 9 mesi di gravidanza.
Inoltre i neonati allattati esclusivamente al seno per i primi 6 mesi di vita sono maggiormente protetti da allergie, asma, dermatiti, diabete mellito, obesità, SIDS e dalla celiachia.
Se poi il bambino è nato prematuro, ancor più di fondamentale importanza per la sua salute è nutrirlo con latte umano, magari proveniente dalle Banche del latte che raccolgono questo prezioso alimento da donne che scelgono liberamente di donarlo.

Anatomia della mammella e fisiologia della lattazione



Fra gli ormoni che influiscono sul processo della lattazione, i più importanti sono:

- **prolattina**
- **ossitocina**

La prima è responsabile della produzione del latte agendo sui lattociti.

La seconda è responsabile dell'emissione del latte poichè agisce sulle cellule muscolari che si contraggono e spingono il latte verso il capezzolo.

Altro ormone che interviene nella regolazione del latte è il **fattore di inibizione della lattazione**, prodotto dalle cellule alveolari, che fa diminuire la produzione di latte quando la mammella è troppo piena.

E' importante sapere che *la quantità di latte prodotta dipende dalla quantità rimossa*.

Questo significa che se un bambino smette di succhiare da un seno, quel seno smette di produrre. Al contrario se succhia di più da una mammella, questa produrrà di più diventando addirittura più grande. Detto ciò la produzione di latte si regola in base alle effettive necessità del neonato seguendo la tipica legge della domanda e dell'offerta: **più il bambino succhia, più latte viene prodotto**. Per favorire un'abbondante produzione l'allattamento dovrà quindi essere a richiesta e non soggetto ad orari vincolanti.

In quale modo allattare?

Come attaccare il tuo bimbo al seno



CORRETTO NON CORRETTO CORRETTO NON CORRETTO

Se l'attacco e la posizione sono adeguati il bambino poppa efficacemente e tu non senti male:

- La bocca è bene aperta e "riempita" dal seno;
- Il mento è a stretto contatto con il seno ed il collo leggermente all'indietro;
- Il labbro inferiore è rovesciato in fuori (senza che il bambino se lo succhi);
- La punta della lingua si estende oltre la gengiva inferiore e i bordi della lingua avvolgono il seno formando una "U";
- Si vede più areola (la parte scura intorno al capezzolo), sopra al labbro superiore piuttosto che sotto a quello inferiore;
- Il ritmo delle suzioni varia durante la poppata; si passa da suzioni brevi e frequenti a suzioni meno frequenti con movimenti della bocca ampi e profondi, talora intervallati da pause.

L'attacco inadeguato porta a delle conseguenze di non poco conto, come:

- capezzoli dolenti con ragadi
- ingorgo mammario
- poca produzione → bimbo sempre insoddisfatto → scarso aumento di peso.

Spesso le cause di un attacco inadeguato sono invece: l'uso del biberon prima ancora che si sia stabilizzato l'allattamento, inesperienza della madre, difficoltà di tipo funzionale, come un bimbo piccolo e debole, capezzolo protrattile, ingorgo, e anche la mancanza di sostegno da parte di una persona competente. *Nessuna donna alla prima esperienza sa già esattamente come fare: prenditi del tempo per entrare in sintonia con il tuo bambino e non esitare a chiedere aiuto a personale qualificato.*

Le posizioni per allattare



Posizione classica
La testa del bambino poggia sull'avambraccio dello stesso lato del seno utilizzato.



Posizione incrociata.
Il bambino è tenuto con il braccio opposto rispetto al seno utilizzato. La mano della mamma gli sorregge la nuca.



Posizione rugby
Il bambino è sottobraccio alla mamma con i piedini che puntano all'indietro.



Posizione sdraiata
La mamma tiene il bambino sdraiato vicino a sé.

Le posizioni per l'allattamento sono moltissime, la cosa più importante è mettersi comodi e trovare una posizione in cui ci si senta a proprio agio prima di cominciare ad allattare, anche se si può cambiare quando si vuole.

Puoi allattare in molti modi, (anche stando in piedi!) l'importante è che tu ti senta comoda e rilassata e che tu ed il tuo bambino siate in una posizione che renda facile la poppata.
All'inizio potresti trovare più confortevole una certa posizione, come per esempio stare seduta sulla tua seggiola preferita, o sdraiata a letto.
Mano a mano che tu ed il tuo bambino diventerete più esperti, sarai capace di nutrire tuo figlio ovunque, mentre cammini, mentre lo porti nella fascia, mentre stai mangiando seduta a tavola.

Cura del seno

Il seno non ha bisogno di molta cura, è sufficiente la normale igiene della mamma con lavaggio quotidiano anche solo con acqua.
Non è necessario lavare il seno prima o dopo ogni poppata.
Va evitato però l'uso di creme, unguenti e saponi profumati, poiché possono confondere il sapore e l'odore naturale che secernano le ghiandole sebacee presenti nell'areola (di Montgomery), che sono un richiamo olfattivo per il bambino.



Il sapore del latte materno

Il sapore del latte materno dipende dalla dieta della madre.
Più l'alimentazione è varia, più il latte cambia il suo sapore e queste variazioni abituano il bimbo ai cibi e lo preparano allo svezzamento.
Inoltre la dieta della madre, qualunque essa sia non influenza la composizione del latte.

Bisogni nutrizionali di una donna che allatta

Tutte le madri che allattano devono mangiare e bere abbastanza da sentirsi bene ed essere capaci di produrre latte. Rispetto ad una donna che non allatta servono solo 500 calorie in più al giorno seguendo una dieta varia per una buona produzione. E' consigliato bere 2 litri di acqua al giorno, ed è sconsigliato l'uso di alcol.

Conservazione del latte materno

Il latte materno è un dono prezioso

Il latte materno è un dono prezioso e per questo non va mai sprecato!
Oltre ad essere succhiato direttamente del neonato, può essere tirato e conservato per svariati motivi quali reinserimento della madre nel lavoro, terapie mediche della madre (non compatibili per l'allattamento) per brevi o lunghi periodi.
Il seno è una fabbrica di latte che aumenta la velocità di produzione quanto più latte viene fatto uscire, quindi tirarlo contribuisce ad una sua maggiore produzione!

Latte materno fresco

- A °37 - 25 C per 4 ore
- A °25 - 15 C per 8 ore
- A meno di °15 C per 24 ore
- Non conservare a temperature più alte di °37 C

Latte materno refrigerato

- A °4 – 2 C fino ad 8 giorni

Latte materno congelato

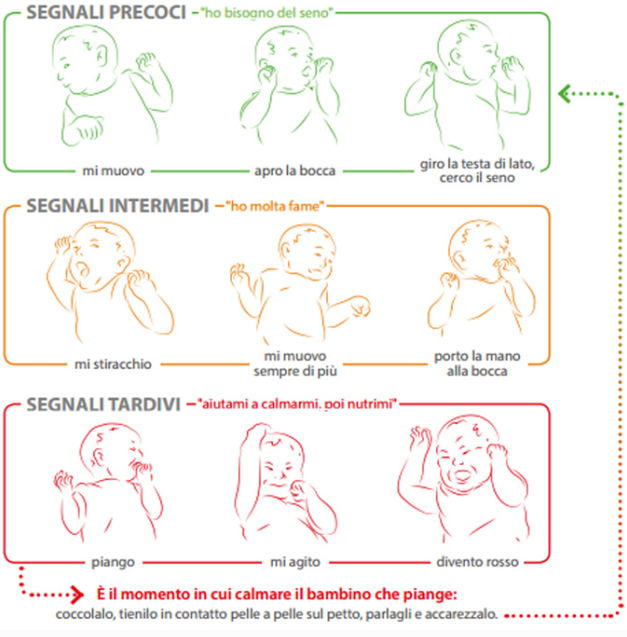
- Nel comparto congelatore di un frigorifero 2 settimane
- Nel comparto congelatore di un frigorifero congelatore 3 mesi
- In un congelatore separato a bassa temperatura 6 mesi
- Scongelalo lentamente in frigorifero o a bagnomaria e ricordati che va consumato entro 24 ore e non va ricongelato.



Come capire se il bimbo ha fame?

Il bambino dice “ho bisogno del seno!”

Sarà il bambino stesso a farti capire quando sarà arrivato il momento per la poppata.
Quindi: osserva il bambino e non l’orologio!
I primi segnali, con cui il bambino ti comunica che ha bisogno di andare al seno sono: muovere o allungare le braccia, sbadigliare, aprire gli occhi, far sporgere la lingua dalla bocca, girare il capo da un lato all’altro, mettersi le manine in bocca.
Il pianto è un segnale tardivo e può rendere più difficile attaccare il bambino al seno. Cerca quindi di cogliere i segnali che precedono il pianto per offrire il seno.



Alcune mamme temono che pasti frequenti vogliano dire poco latte, ma se pensiamo alle dimensioni del pancino del bambino, è del tutto normale!
Quando il piccolo è attaccato bene al seno, tutte le volte e quanto a lungo desidera, produrrai latte a sufficienza per le sue necessità.
Ogni volta che il bambino si attacca al seno e poppa, stimola la tua produzione.



La suzione del bambino invia dei segnali a una ghiandola del cervello (l’ipofisi) che manda al seno segnali che fanno produrre più latte.



Meno si allatta e minore sarà la produzione di latte!

Problemi del seno precoci e tardivi

Durante l'allattamento possono insorgere problemi o patologie che possono comprometterne la buona riuscita se non tempestivamente ed appropriatamente trattati. Nella maggior parte dei casi derivano da una NON corretta gestione dell'allattamento materno (attacco, posizione e frequenza).
I principali problemi sono:

• Le ragadi • L'ingorgo mammario • Il dotto ostruito • La mastite

LE RAGADI sono delle lesioni del capezzolo e sono il risultato di un cattivo attacco e di un'errata posizione durante l'allattamento per cui il bambino ha succhiato con troppa forza per ricevere il latte. Non va limitata la frequenza delle poppate e tantomeno smettere per far riposare il seno. Bisogna trattare le cause, aiutando la madre con posizione ed attacco.
Una buona soluzione per lubrificare ed ammorbidire i tessuti è applicare latte spremuto sui capezzoli dopo le poppate, applicare un impacco caldo al seno prima delle poppate per stimolare il riflesso ossitocinico e iniziare la poppata dal seno meno colpito. Se la lesione non tende a risolversi entro le 48 ore la donna dovrebbe richiedere una consulenza all'ostetrica o al medico.

L'INGORGO MAMMARIO si verifica quando la mammella non viene svuotata del tutto o nella stessa frequenza. Il seno diventa molto caldo, duro e dolente, appare teso e lucido. Il capezzolo assume una forma stirata, teso e appiattito rendendo difficile l'attacco del bambino. Per risolvere l'ingorgo bisogna rimuovere il latte con l'utilizzo di un tiralatte o spremitura manuale. Va inoltre incrementata la frequenza dell'attacco, offrendo al bambino per primo il seno con ingorgo. Una doccia o un bagno caldo possono aiutare a fare uscire il latte.

IL DOTTO OSTRUITO può causare infiammazione dei tessuti fino alla mastite non infettiva. Anche questo problema è riconducibile a poppate poco frequenti e a una rimozione inadeguata di latte da una zona del seno. La soluzione è quella di aumentare le poppate, variando la posizione in modo da drenare la mammella nelle varie parti. Per la riduzione dei sintomi può essere utile un antinfiammatorio, come ibuprofene o paracetamolo.

LA MASTITE è l'estrema conseguenza dell'ingorgo mammario e del dotto ostruito non trattati! E' una condizione di infiammazione del tessuto mammario in cui si sovrappone un'infezione batterica, favorita da lesioni del capezzolo che rappresentano una porta di ingresso per i germi.
Il trattamento per la mastite è:
• Controllare l'attacco e, se necessario, correggerlo
• Evitare la pressione da parte di indumenti stretti
• Facilitare il deflusso del latte, oltre che con poppate frequenti con massaggi delicati in direzione del capezzolo e impacchi caldi nell'area colpita prima della poppata
• Continuare a rimuovere il latte dalla mammella con l'aiuto di un tiralatte o con spremitura manuale
• Assicurare che la madre stia qualche giorno a riposo

Per quanto riguarda la terapia antibiotica, è indicata se c'è febbre o se i sintomi non recedono dopo le 24 ore di poppate frequenti ed efficaci o spremitura del latte. Per il controllo del dolore invece si può associare un analgesico come paracetamolo o l'antinfiammatorio ibuprofene.



Farmaci e allattamento al seno

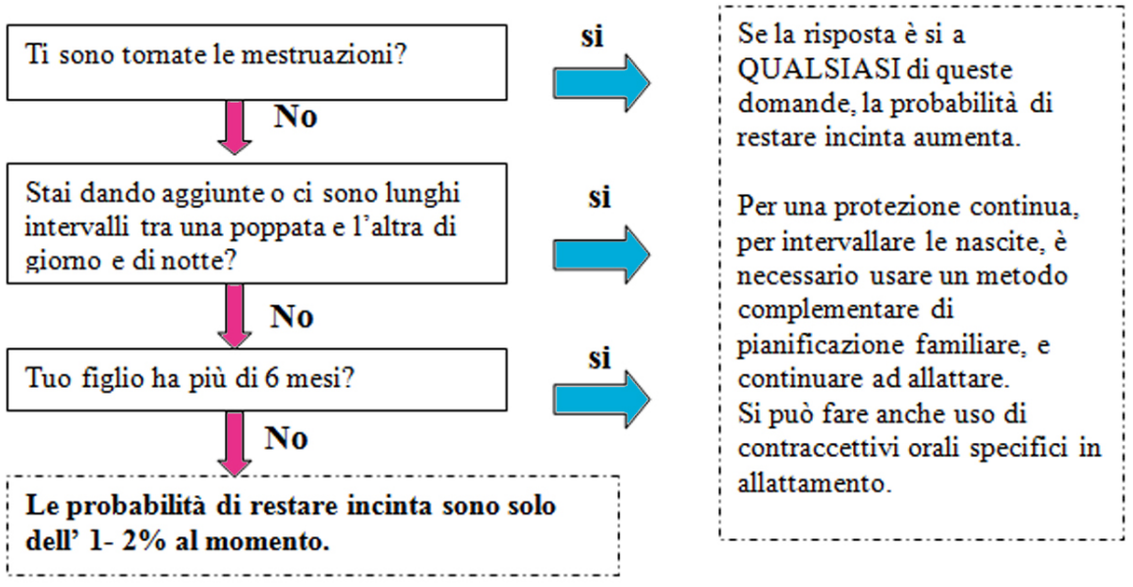
L'uso di farmaci durante l'allattamento è una situazione frequente e spesso si verifica però che, per eccesso di cautela, si arrivi o ad una sospensione dell'allattamento o alla rinuncia della madre a sottoporsi ad un trattamento farmacologico.
Gran parte dei farmaci passano nel latte della madre solo in piccole quantità e solo poco dopo averlo assunto, le controindicazione assolute all'uso dei farmaci sono poche.
Per prima cosa sarebbe meglio assumere la terapia subito dopo l'ultima poppata ed evitare l'allattamento per la prima ora dopo l'assunzione, periodo che corrisponde alla massima concentrazione plasmatica del farmaco.
Sarebbe utile far trascorrere un intervallo di 4 ore tra l'assunzione del farmaco e la poppata successiva.
Curarti è un tuo diritto e non è in conflitto con il diritto del tuo bambino di essere allattato! Fai riferimento al tuo medico curante o ad altri specialisti per ricevere informazioni sui medicinali di cui hai bisogno. E' meglio evitare il "fai da te", non tutti i farmaci da banco o i prodotti di erboristeria sono indicati in corso di allattamento al seno.
Se devi assumere farmaci controindicati in corso di allattamento al seno (come radioisotopi per la scintigrafia), potrai decidere di tirare il latte e gettarlo via per il tempo di eliminazione della sostanza chimica. Per consentire un'agevole ripresa dell'allattamento, alla fine di questo periodo, bisogna mantenere la produzione di latte, per fare ciò bisogna tirare il latte con la stessa frequenza delle poppate del bambino, se si limita la spremitura a sua volta la produzione del latte diminuirà non soddisfacendo le necessità alimentari del bimbo.
Infine se stai allattando e sai in anticipo quando dovrai assumere farmaci controindicati, potrai organizzarti con il tiralatte ed iniziare a mettere da parte delle poppate, da utilizzare quando non si potrà allattarlo direttamente al seno.

Numero Verde CENTRO ANTIVELENO BERGAMO

Numero Verde
800.883300

24/24 H puoi chiedere informazioni
sui farmaci in gravidanza e allattamento

Amenorrea da Allattamento



Risorse web e informazioni sull'allattamento

* TAS - Tavolo tecnico operativo interdisciplinare sull'Allattamento al Seno
www.salute.gov.it/portale/temi/allattamento
* La Leche League - www.lllitalia.org
* UNICEF Italia - www.unicef.it
* Movimento Allattamento Materno Italiano - www.mami.org
* Ibfan Italia - www.ibfan.org
* Associazione Consulenti Professionali - www.aicpam.org
* La Gazzetta della Prolattina- www.lagazzettadella prolattina.it
* Genitori Più - www.genitoripiu.it
* Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato - www.aiblud.com
* Federazione Nazionale Collegi Ostetriche - www.fnco.it
* Telefono rosso del Policlinico Universitario Gemelli di Roma
TEL 3050077-06
* Tossicologia perinatale dell'Azienda Ospedaliera Carreggi di Firenze
TEL 4277731-055



il latte materno
ha 3 ingredienti speciali:

Amore
Dedizione,
Pazienza